# DIFERENCIAS POR GÉNEROS Y LUGAR DE NACIMIENTO EN LA PERCEPCIÓN DE CALIDAD DEVIDA Y ESTIGMA EN LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH

Melchor Riera Jaume 1, Paula Carretero Cuenca 2, Francisco Javier Fanjul 1, Adrian Rodriguez Rodriguez 3, Joaquin Serrano 3, Aroa Villoslada 3, Gabriel Mercadal Orfila 4, Tomas Mijares Boeckh-Behrens 4, Luis Vidal 4, Maria L Martin 1, Javier Murillas Angoiti.

1Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, 2UIB, Palma de Mallorca, 3Fundación Hospital Son Llátzer, Son Ferriol, 4Hospital Mateu Orfila, Maó

eVIHa COHORTE BALEAR

CC BY NC ND

## OBJETIVOS

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y el estigma constituyen factores determinantes en el bienestar de las personas que viven con VIH (PVVIH). El objetivo fue analizar las diferencias en CVRS y estigma percibido según género y lugar de nacimiento mediantecuestionarios validados.

## MATERIAL/MÉTODOS

Para la realización de los cuestionarios se utilizó el aplicativo móvil NAVETA (_____), previa explicación de su utilización, en los pacientes en seguimiento de la cohorte eVIHa en HUSE desde Enero 2022.

HRQoL fue medido mediante el autocuestionario WHQoL-HIV-Brief que comprende 31 ítems: 1 de HRQoL global, 1 de salud general, y 29 que cubren 6 dominios: Salud Física, Salud psicológica, nivel de independencia, relaciones sociales, salud ambiental, espiritualidad y religión y creencias personales.

Calculamos la media y el IC 95%, para cada ítem (entre 1-5) y del dominio (entre 4-20), un score mas elevado expresa una mejora calidad de vida. Se compararon las medias mediante test Anova con análisis Bonferroni y B Tukey.

## RESULTADOS

Se incluyeron 1.334 participantes (1.065 hombres, 269 mujeres; 919 europeos, 311 latinoamericanos).

Las mujeres presentaron mayor edad, peor situación laboral, más comorbilidades (Charlson≥3: 28% vs 19,2%), mayor tiempo de infección VIH (26 vs 14 años), estadios más avanzados y menor adherencia (Ver tabla 1) . En el WHOQoL-HIV, los hombres reportaron puntuaciones superiores en CVRS, especialmente en dominios físico, psicológico y nivel de independencia. Las mujeres obtuvieron puntuaciones más elevadas en la escala NEURO-QoL Stigma, indicando mayor estigma percibido.(tabla 2)

Respecto al lugar de nacimiento, las personas de Latinoamérica eran más jóvenes (44 vs 52 años),con mayor proporción de mujeres (29% vs 22%) y universitarios (22% vs 13%), pero tasas de desempleo superiores. Presentaron menor tiempo de infección y menos comorbilidades. No se encontraron diferencias significativas en CVRS global, excepto en el dominio físico (puntuaciones superiores en latinoamericanos). Los europeos reportaron más dolor físico, mientras que los latinoamericanos manifestaron más tristeza, ansiedad y miedo a la muerte. No se observaron diferencias en estigma según origen.

En el análisis multivariante, ni el género ni el lugar de nacimiento influyeron significativamente en la CVRS global, aunque sí impactaron en dominios específicos

La ecuación estimada del modelo en el cuestionario WHOQoL fue:

*CVRS = 13,046 + 1,017 (nivel educativo) + 0,487 (hábito alcohol) – 0,293 (comorbilidades)*

Tabla 1. Características de los PVVIH incluidos según genero

| Tabla 1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Variable** | **Masculino (n=1005)** | **Femenino (n=269)** | **p-valor** |
| **Edad (media)** | 50,192 | 52,246 | 0,006 |
| **Lugar de Nacimiento** | | | <0.0001 |
| - Europa | 719 (71,5%) | 200 (74,3%) | |
| - América Latina | 263 (26,2%) | 50 (18,6%) | |
| - Otros | 23 (2,3%) | 19 (7,1%) | |
| **Hábito tabaco** | | | 0.862 |
| - Fumador | 331 (32,9%) | 93 (34,6%) | |
| - Ex fumador | 189 (18,8%) | 48 (17,8%) | |
| - No fumador | 485 (48,3%) | 128 (47,6%) | |
| **Hábito alcohol** | | | 0.014 |
| - Bebedor | 216 (21,5%) | 43 (16,0%) | |
| - Ex bebedor | 15 (1,5%) | 0 (0,0%) | |
| - No bebedor | 774 (77,0%) | 226 (84,0%) | |
| **Nivel de educación** | | | 0.317 |
| - Primaria | 109 (10,8%) | 23 (8,6%) | |
| - Secundaria | 252 (25,1%) | 39 (14,5%) | |
| - Universitaria | 175 (17,4%) | 23 (8,6%) | |
| - Desconocido | 469 (46,7%) | 184 (68,4%) | |
| **Número de comorbilidades** | | | 0.003 |
| - Cero | 400 (39,8%) | 77 (28,6%) | |
| - Una o dos | 404 (40,2%) | 123 (45,7%) | |
| - Tres o más | 201 (20,0%) | 69 (25,7%) | |
| **Indice de Charlson** | | | <0.0001 |
| - Cero | 626 (62,3%) | 132 (49,1%) | |
| - Uno o dos | 186 (18,5%) | 62 (23,0%) | |
| - Tres o más | 193 (19,2%) | 75 (27,9%) | |
| **Carga viral** | | | >0.05 |
| - Detectable | 44 (4,4%) | 8 (3,0%) | |
| - Indetectable | 959 (95,6%) | 261 (97,0%) | |
| **Estadio CDC VIH** | | | <0.0001 |
| - A | 739 (73,5%) | 143 (53,2%) | |
| - B | 114 (11,3%) | 63 (23,4%) | |
| - C | 152 (15,1%) | 63 (23,4%) | |
| **Situación laboral** | | | 0.043 |
| - Asalariado u otros | 457 (45,5%) | 112 (41,6%) | |
| - Autónomo | 88 (8,8%) | 10 (3,7%) | |
| - Desempleado | 85 (8,5%) | 29 (10,8%) | |
| - Jubilado o invalidez | 68 (6,7%) | 23 (8,5%) | |
| - Desconocido | 307 (30,5%) | 95 (35,3%) | |
| **Grupo de riesgo** | | | <0.0001 |
| - HSH (Hombres que tienen sexo con hombres) | 658 (65,5%) | 2 (0,7%) | |
| - Heterosexual | 167 (16,6%) | 187 (69,5%) | |
| - UDI (Usuarios de drogas inyectables) | 117 (11,6%) | 58 (21,6%) | |
| - UDI+HSH | 4 (0,4%) | 2 (0,7%) | |
| - Transfusión | 4 (0,4%) | 1 (0,4%) | |
| - Filial (pareja serodiscordante) | 10 (1,0%) | 12 (4,5%) | |
| - Desconocido | 45 (4,5%) | 7 (2,6%) | |
| **Adherencia media últimos 2 años (mediana y DE)** | 82 (67-94) | 73,5 (58-88) | <0,0001 |
| **Años desde el diagnóstico de VIH (mediana y DE)** | 14 (8-24) | 26 (13-33) | <0,0001 |
| **Meses en tratamiento (mediana y DE)** | 126 (69-222) | 229 (101-317) | <0,001 |
| **CD4 nadir (mediana y DE)** | 477 (267-713) | 403 (221-669) | 0,025 |
| **CD4 actual (mediana y DE)** | 870 (628-1106) | 844(584-1113) | 0,646 |

Tabla 2. Análisis de los resultados de los cuestionarios por generos

| Cuestionario | Masculino (Media ± DE) | Femenino (Media ± DE) | p-valor |
|---|---|---|---|
| **WHOQoL Dominio fisico** | 15,251 ± 3,1501 | 14,112 ± 3,7130 | <0,0001 |
| **WHOQoL Dominio psicológico** | 14,864 ± 2,9542 | 13,951 ± 3,0628 | <0,0001 |
| **WHOQoL Nivel de independencia** | 15,174 ± 3,1687 | 14,320 ± 3,6006 | <0,0001 |
| **WHOQoL Relaciones sociales** | 14,874 ± 3,3198 | 14,230 1 ± 3,4661 | 0,007 |
| **WHOQoL Entorno** | 15,107 ± 2,4168 | 14,743 ± 2,4920 | 0,033 |
| **WHOQoL creencias** | 14,875 ± 3,5237 | 13,766 ± 3,7148 | <0,001 |
| **PROMIS** | 46,632 ± 9,2804 | 47,022 ± 8,8761 | 0,600 |
| **NEURO-QoL Stigma** | 50,996 ± 7,1528 | 52,338 ± 7,0871 | 0,011 |

**Tabla 3. Análisis de los resultados de los cuestionarios por lugar de nacimiento**

| Cuestionario | Europa (Media ± DE) | América Latina (Media ± DE) | Otros (Media ± DE) | p-valor |
|---|---|---|---|---|
| **WHOQOL Dominio fisico** | 14,879 ± 3,4324 | 15,383 ± 2,8890 | 15,095 ± 3,3262 | 0,047 |
| **WHOQOL Dominio psicológico** | 14,613 ± 3,0696 | 14,781 ± 2,8015 | 15,124 ± 2,8753 | 0,424 |
| **WHOQOL Nivel de independencia** | 14,972 ± 3,4190 | 15,067 ± 2,8631 | 14,929 ± 3,1960 | 0,899 |
| **WHOQOL Relaciones sociales** | 14,778 ± 3,3181 | 14,674 ± 3,4076 | 14,333 ± 3,9303 | 0,066 |
| **WHOQOL Entorno** | 15,100 ± 2,4674 | 14,914 ± 2,2594 | 14,393 ± 2,9208 | 0,114 |
| **WHOQOL Creencias** | 14,632 ± 3,5338 | 14,693 ± 3,7152 | 14,429 ± 3,9887 | 0,897 |
| **PROMIS** | 46,869 ± 9,2737 | 46,677 ± 9,0162 | 44,850 ± 9,6430 | 0,476 |
| **NEURO-QoL Stigma** | 51,382 ± 7,2516 | 51,220 ± 6,8276 | 49,846 ± 7,4811 | 0,417 |

## CONCLUSIONES

Las mujeres presentaron puntuaciones inferiores en CVRS y puntuaciones mas elevadas en NEURO-QoL Stigma. Las diferencias observadas en CVRS por género y lugar de nacimiento se explican principalmente por diferencias en edad, comorbilidades y nivel educativo, destacando la importancia de abordar estos factores de forma integral en el manejo clínico de PVVIH.